DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2025.08.009

·康复教育·

智力与发展性残疾儿童言语和语言功能特点及教育课程和康复方案:基于ICF的研究

李莎[1,2,3]，邱卓英[4,5]

1. 邯郸学院特殊教育学院,河北邯郸市 056005;2. 河北省特殊教育质量评估与教师发展中心,河北邯郸市 056005;3. 河北省特殊教育协同创新中心,河北邯郸市 056005;4. 康复大学社会发展学院/国际康复政策和ICF研究中心,山东青岛市 266113;5. 世界卫生组织国际分类家族中国合作中心,北京市 100068

通信作者:邱卓英,E-mail: qiutiger@hotmail.com

基金项目:河北省特殊教育协同创新中心科研项目(No. XC250202)

摘要

目的 本研究基于《国际功能、残疾和健康分类》(ICF)的功能架构，系统探讨智力与发展性残疾(IDD)儿童的言语与语言功能特点，并且在对培智学校语言与适应相关课程标准内容和功能目标分析基础上，构建一个教康融合的体系。

方法 运用ICF的生物-心理-社会模型，从身体功能与结构、活动和参与、环境因素3个维度，系统梳理IDD儿童的言语及沟通障碍特征。对中国教育部颁布的三大培智学校核心课程标准进行内容分析，提取并归纳其中与语言能力发展相关的目标和核心内容，并运用ICF分类体系进行映射和编码。基于ICF功能导向原则，融合课程目标与循证康复策略，构建一个包含评估、目标设定、课程模块设计和干预策略的综合性课程和康复体系。

结果 IDD儿童的语言与言语功能发展在身体功能层面涉及语言的心理功能(b167)、构音功能(b320)等损伤，活动和参与层面表现为沟通(d3)、人际交往(d7)等方面的显著困难，环境因素(如家庭支持e310、教育服务e585)对其功能表现和适应有决定性影响。我国培智学校语言功能相关的主要课程标准分别从身体功能(《康复训练课程标准》)、沟通交流技能(《生活语文课程标准》)和社会参与以及环境(《生活适应课程标准》)3个领域，针对特殊儿童提供了言语和语言功能的教育课程和康复干预标准体系。

结论 儿童言语康复与语言和适应教育是一个复杂而多维的系统工程。以ICF的生物-心理-社会模型为理论，整合中国培智学校《生活语文课程标准》《康复训练课程标准》和《生活适应课程标准》，构建了一个以儿童的言语和语言功能为导向的言语康复方案和语言与适应能力发展相关的课程体系，强调从功能性评估出发，在真实的生活情境中，通过跨学科合作，为每一位特殊需要儿童提供个别化、多模式、循证的教育、康复干预和支持。通过实施整合性的康复干预方案和语言相关的课程体系，提升儿童的言语和语言功能，促进儿童的功能性沟通，赋能特殊儿童的交流活动和社会参与，提升其社会适应能力和综合发展水平。

关键词 智力与发展性残疾；语言；国际功能、残疾和健康分类；生活语文；言语治疗

Characteristics of speech and language functioning in children with intellectual and developmental disabilities and their educational curricula and rehabilitation interventions: an ICF-based study

LI Sha[1,2,3], QIU Zhuoying[4,5]

1. School of Special Education, Handan University, Handan, Hebei 056005, China; 2. Hebei Provincial Center for Special Education Quality Assessment and Teacher Development, Handan, Hebei 056005, China; 3. Hebei Special Education Collaborative Innovation Center, Handan, Hebei 056005, China; 4. School of Social Development/International Cen-

作者简介：李莎(1983-)，女，汉族，河北邯郸市人，博士，讲师，主要研究方向：融合教育、特殊儿童心理与教育、特教教师教育、特殊需求学生功能评估、ICF。通信作者：邱卓英(1962-)，男，汉族，湖北武汉市人，博士，研究员、教授、世界卫生组织国际分类家族中国合作中心联席主任，主要研究方向：ICF、康复心理学、残疾与康复政策、康复科学、康复信息与康复数据科学。

中国知网 https://www.cnki.net

ter for Rehabilitation Policy and ICF Research, University of Health and Rehabilitation Sciences, Qingdao, Shandong 266113, China; 5. WHO-FIC Collaborating Center in China, Beijing 100068, China

Correspondence to *QIU Zhuoying,* E-mail: qiutiger@hotmail.com

Supported by Scientific Research Project of Hebei Provincial Collaborative Innovation Center for Special Education (No. XC250202)

Abstract

Objective To systematically explore the characteristics of speech, language functioning and adaptation in children with intellectual and developmental disabilities (IDD) based on framework of International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), to construct an integrated system that merges curricula and rehabilitation based on an analysis of the content and functional goals within language-related curriculum standards for Peizhi (special education for children with IDD) schools.

Methods Using the bio-psycho-social model of the ICF, the characteristics of speech and communication disorders in children with IDD were systematically analyzed across the three dimensions of body functions and structures, activities and participation, and environmental factors. A content analysis was conducted on the three core curriculum standards for Peizhi schools issued by the Ministry of Education of China, extracting and summarizing the goals and core content related to linguistic ability development, which were then mapped and coded using the ICF classification system. Guided by the ICF's functioning-oriented principles, these curriculum goals were integrated with evidence-based rehabilitation strategies to construct a comprehensive curriculum and rehabilitation interventions that included assessment, goal setting, curriculum module design and intervention strategies.

Results For the speech and language functioning in children with IDD, at the body functions level, impairments were identified in areas such as mental functions of language (b167) and articulation (b320); at the activities and participation level, limitations manifested as significant difficulties in communication (d3) and interpersonal interactions (d7); and environmental factors (e.g., family support, e310; educational services, e585) impacted on functional performance and adaptation. Main curriculum standards of China related to language functioning for Peizhi schools addressed three domains respectively: body functions (Rehabilitation Training Curriculum Standard), communication skills [Living Language (Chinese) Curriculum Standard], and social participation and environment (the Life Adaptation Curriculum Standard). Together, they constructed a standardized system for educational curricula and rehabilitation interventions for children's speech and language functioning.

Conclusion The speech therapy, the courses of Chinese language and adaptation are the complex and multidimensional processes. Based on the theoretical framework of the ICF's bio-psycho-social model, this study systematically integrates China's Living Language (Chinese), Rehabilitation Training, and Life Adaptation curriculum standards to construct a speech rehabilitation program and a language ability curriculum oriented by the children's speech, language functioning and adaptation, which emphasizes a process beginning with functional assessment, grounded in real-life contexts, and actualized through interdisciplinary collaboration, to provide individualized, multimodal and evidence-based education, rehabilitation interventions and support for every child with special needs. By implementing the integrated rehabilitation interventions and language-related curriculum system, it enhances children's speech, language functioning and adaptation, promotes their functional communication, empowers their communication activities and social participation, and improves their social adaptation and overall development.

Keywords: intellectual and developmental disabilities; language ability; International Classification of Functioning, Disability and Health; living Chinese language; speech therapy

[中图分类号] R749.93 [文献标识码] A [文章编号] 1006-9771(2025)08-0930-09

[本文著录格式] 李莎,邱卓英. 智力与发展性残疾儿童言语和语言功能特点及教育课程和康复方案：基于ICF的研究[J]. 中国康复理论与实践, 2025, 31(8): 930-938.

CITED AS: LI Sha, QIU Zhuoying. Characteristics of speech and language functioning in children with intellectual and developmental disabilities and their educational curricula and rehabilitation interventions: an ICF-based study [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2025, 31(8): 930-938.

中国知网 https://www.cnki.net

0 引言

语言是人类最重要的交际工具和信息载体，是思维发展、文化传承和社会交往的基石。儿童时期的语言发展对其社会心理健康、学业成就乃至长期福祉具有至关重要的预测作用[1]。根据美国智力与发展障碍协会的定义，智力与发展性残疾(intellectual and developmental disabilities, IDD)是指一组在发育阶段起病的长期性障碍，表现为认知、适应行为、语言、社交、运动或学习等方面的显著受限[2-3]。这类残疾通常在22岁前出现，影响个体的独立生活能力和社会参与需求。IDD包括但不限于智力残疾、孤独症谱系障碍(autism spectrum disorder, ASD)、注意缺陷多动障碍(attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)、特定学习障碍(读写障碍、计算障碍)、发育性语言障碍、发展性协调障碍(developmental coordination disorder, DCD)以及遗传综合征相关障碍(如唐氏综合征)等[4-5]。根据《国际疾病分类第十一次修订本》(International Classification of Diseases, the 11th Revision, ICD-11)，这些障碍都属于神经发育障碍大类，包括智力发育障碍(6A00)、孤独症谱系障碍(6A02)、发育性言语与语言障碍(6A05)等。IDD儿童的挑战之一便是显著的言语与语言发展障碍，通常伴随着不同程度和类型的沟通障碍[6]。这些沟通困难不仅阻碍儿童的知识学习和社交互动，还常常是导致行为异常的主要原因之一[7]。

IDD儿童有一部分需要接受特殊教育，在中国主要是在培智学校接受教育。在特殊教育情境下，通过特殊教育的课程对儿童的言语与语言功能进行教育和康复是事关重大的措施。中国教育部为培智学校专门制定并颁布《生活语文课程标准》[8]《康复训练课程标准》[9]和《生活适应课程标准》[10]，这三大课程标准共同构成我国培智学校义务教育的语言类课程核心框架。其中，《生活语文课程标准》强调语言的工具性、人文性与生活性；《康复训练课程标准》聚焦于功能改善与潜能开发；《生活适应课程标准》则致力于帮助学生学会生活、融入社会。这三大课程标准虽各有侧重，但都内在地指向提升IDD儿童语言及沟通能力这一共同目标。

在实践层面，IDD儿童的语言能力培养仍面临挑战。传统模式下，学校的“教育”与医疗康复机构的“康复”往往被分割在不同场域，由不同体系的专业人员执行，导致服务碎片化、目标不统一、干预不连续。学生在康复机构习得的言语技能，可能难以泛化到学校的真实学习和生活情境中；而学校教师在面对儿童复杂的言语功能障碍时，又常感缺乏系统的康复理论与技术支持。这种“教”与“康”的分离，阻碍对儿童语言能力的整体性、功能性培养。

因此，迫切需要一个能够整合教育目标与康复原则的、科学的、整体性的概念架构，来指导培智学校的课程设计与教学和康复实践。世界卫生组织(World Health Organization, WHO)发布的《国际功能、残疾和健康分类》(International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF)采用生物-心理-社会模型，从身体功能与结构、活动和参与以及环境因素3个层面全面描述个体的健康、功能与残疾状况[11]。本研究旨在运用ICF理论架构，系统探讨IDD儿童言语与语言能力的发展与特点。在此基础上，构建一个融合生活语文、康复训练和生活适应课程内容与目标，促进培智学校IDD儿童的言语能力与语言能力发展、基于ICF功能导向的生活语文和言语康复训练的康复-教育融合方案，推动针对IDD儿童言语和语言能力的跨学科合作、情境化干预的模式转变，促进儿童的功能性沟通，提升其社会适应能力和综合发展水平。

1 IDD儿童的言语与语言功能形成与发展：基于ICF的分析

为了全面理解IDD儿童的语言障碍，本研究采用ICF的整体性架构进行分析，系统梳理IDD儿童在ICF身体功能、活动和参与以及环境因素3个核心维度上的常见言语与语言功能特征。见表1 。

在身体功能层面，IDD儿童沟通困难的根源在于多重损害。不仅包括通常被关注的语言心理功能(b167)，还可能涉及更基础的言语产生机制(b3)和注意功能(b140)。这意味着有效的干预不能仅停留在语言知识的教授上，还必须针对其核心功能障碍提供专业的康复训练[7]。

在活动和参与层面，IDD儿童的言语与语言功能受限直接影响其日常表现。如儿童词汇量小(b167损伤)会直接导致他在课堂上无法回答问题、无法和同伴谈论动画片(d350、d710受限)。这种从“损伤”到“功能受限”的视角转换至关重要，它要求干预目标必须是功能性的，即直接指向改善儿童在日常生活、学习和社交中的实际表现[1,12]。

环境因素在儿童语言发展中起到关键调节作用。一个充满支持、鼓励和专业服务的环境，能够极大地弥补儿童身体功能的不足，促进其活动和参与水平的

中国知网 https://www.cnki.net

表1 基于ICF的IDD儿童言语与语言功能特征分析

Table 1 Analysis of speech and language functioning characteristics of children with IDD based on ICF

ICF维度	ICF编码	ICF类别	IDD儿童的常见特征描述
身体功能与结构	b167	语言精神功能	语言习得延迟,词汇量不足,词语使用不当 语法规则掌握困难,难以理解和产出复杂句 接受性和表达性语言发展不均衡
	b320	构音功能	发音不清,存在音素的替代、省略或歪曲,导致言语清晰度低
	b330	言语的流畅和节律功能	可能伴有口吃、语速异常或不流畅等问题
	b140	注意力功能	共同注意、持续注意困难,影响语言信息的输入和学习
	s320-s340	参与发声和言语的结构	部分儿童可能伴有唇腭裂等物理结构异常,直接影响言语产生
活动和参与	d310	交流-接收-口头讯息	难以理解他人的口头指令,特别是长指令或复杂指令 对语境线索理解不足
	d330	说	表达性词汇量有限,句子简短,语法结构单一 难以清晰表达自己的需求、想法和情感
	d350	交谈	难以发起和维持对话,轮流转换困难 话题局限,常偏离主题 语用技能不足,如不理解幽默或间接请求
	d710	基本的人际交往	难以建立和维持友谊。 难以理解社会交往中的非语言线索(如面部表情、身体语言)
	d166/d170	阅读/书写	入学后常伴有读写障碍,学习困难
	d820/d920	学校教育/娱乐和休闲	因沟通障碍导致课堂参与困难,难以融入同伴游戏和集体活动
环境因素	e125	用于沟通的产品和技术	缺乏或无法有效使用AAC设备可能成为沟通的障碍,合适的AAC设备是重要的促进因素
	e310/e320	直系亲属家庭/朋友	家庭成员的积极支持、鼓励和有效的沟通互动是关键的促进因素 同伴的接纳与互动提供了宝贵的练习机会
	e355/e360	卫生专业人员/其他专业人员(教师)	早期、持续的专业服务(言语治疗、特殊教育)是重要的促进因素 服务可及性不足则构成障碍
	e410/e460	直系亲属家庭成员的个人态度/社会态度	对残疾的负面态度和污名化是儿童社会融合和沟通意愿的巨大障碍 包容和支持的态度则是重要的促进因素
	e580/e585	卫生服务、体制和政策/教育和培训服务、体制和政策	完善的早期筛查、诊断、康复救助和融合教育政策体系是根本性的促进因素

注:AAC,增强与替代沟通(augmentative and alternative communication)。

提升。反之，一个充满障碍和负面态度的环境，则会加剧其残疾程度[13]。这强调了干预必须是生态化的，需要对儿童所处的物理环境、人际环境和社会政策环境进行系统性的改造和优化，为儿童的语言发展创造最佳的外部条件[14]。

2 培智学校儿童语言能力发展的国家相关课程标准体系与内容:基于ICF的言语与语言功能发展分析

教育部于2016年颁布培智学校儿童的课程标准，与言语和语言能力发展相关的三大核心课程标准包括《康复训练课程标准》《生活语文课程标准》以及《生活适应课程标准》。生活语文课程目标是发展IDD儿童的语言能力的核心课程，三大课程标准共同为IDD儿童的语言能力发展构建一个全面的、多维度的教育框架。表2将三大标准中的核心语言目标与ICF功能目标进行映射，以揭示其内在的功能逻辑结构和联系。

表2清晰地展示我国培智学校课程体系与ICF框架的高度契合性，形成了一个从“功能”到“活动”再到“参与”的完整逻辑链条，充分体现了当代特殊教育从缺陷补偿向功能代偿、社会融合的发展趋势。

《康复训练课程标准》奠定功能基础。该标准直接针对IDD儿童在ICF身体功能层面的核心障碍，如构音、注意和语言认知加工等，提供基础性的康复支持。这解决了儿童语言发展的源动力问题，是后续一

中国知网 https://www.cnki.net

表2 培智学校三大课程标准言语、语言功能以及适应性发展目标

Table 2 Objectives of speech, language functioning and adaptation in three major curriculum standards for IDD special education schools

课程标准	核心课程模块目标与内容	言语与语言功能目标对应的ICF类目和编码
康复训练课程标准	沟通与交往训练模块	身体功能
	言语准备:呼吸、发声、构音训练	b3 发声和言语功能
	前沟通技能:沟通动机、共同注意	b130 能量和驱力功能, b140 注意力功能
	口语沟通:理解词句、运用词组和句子表达	b167 语言精神功能
生活语文课程标准	倾听与说话	活动
	低年级:听懂常用语,表达基本需求	d310 交流—接收—口头讯息,d330 说
	中年级:简单讲述生活事情,参与讨论	d330 说,d350 交谈
	高年级:转述主要内容,表达观点	d330 说,d350 交谈
	识字与写字/阅读/写话与习作	活动
	认读和书写生活常用汉字(姓名、站牌等)	d166 阅读,d170 书写
	阅读简单应用文(购物清单、说明书)	d166 阅读
	填写简单表格,书写简单的应用文(贺卡、短信)	d170 写作
生活适应课程标准	个人生活	参与
	会表达自己的身体感受和情绪情感	d330 说,d5 自理
	家庭生活	
	与亲友沟通交流,承担家庭责任	d350 交谈,d6 家庭生活,d760 家庭关系
	学校生活	
	与师生友好合作,具有团队意识	d710/d720 基本/复杂人际交往,d8 主要生活领域
	社区生活	
	愿意参与社区活动,主动寻求帮助	d730 与陌生人交往,d9 社区、社会与公民生活

切语言学习和应用的前提。

《生活语文课程标准》构建活动技能。该标准聚焦于ICF活动层面，系统地教授儿童在听、说、读、写等方面的具体语言技能 。其内容设计始终贯穿着生活性原则，即所学技能必须是生活中常用和实用的，如认识路牌、填写个人信息等，这确保了语言技能学习的功能导向性。

《生活适应课程标准》指向参与目标。该标准为语言技能的应用提供了真实、多元的社会生活情境，其目标直指ICF的参与层面 。在家庭、学校、社区等真实场景中，儿童学习到的语言技能被赋予了实际的社会功能，如表达需求、建立关系、解决问题等。这使得语言学习不再是孤立的课堂任务，而是融入社会、提升生活质量的根本途径。

由上可见，三大课程标准并非彼此独立，而是构成了一个有机整体。一个理想的培智学校语言教育体系，必须将三者进行深度整合：以生活适应描绘的社会参与蓝图为终极目标，以生活语文教授的功能性语言技能为核心内容，并以康复训练提供的底层功能支持为个体化保障。这种整合思路，与ICF所倡导的、旨在促进个体在真实环境中全面功能的康复理念完全一致。

3 基于ICF的言语康复与语言和适应类课程内容的融合架构设计

基于对培智学校与语言能力发展相关的三大核心课程内容与儿童功能发展的系统分析，本研究基于ICF为架构，构建了针对言语康复与语言和适应相关的课程的基于ICF的融合架构设计，旨在建立培智学校语言与适应相关三大课程标准的综合目标，并且在此基础上设计融合言语康复与语言与适应类课程的方案。见表3 。

言语与语言能力以及综合功能和发展的评估是实现语文课程个别化教育的基础[15]。整个言语康复和语文课程流程始于全面的ICF功能性评估，确保所有后续的教学与康复活动都建立在对学生个体需求的深刻理解之上，真正实现个别化教育计划(individualized education program, IEP)的“量身定制”。

中国知网 https://www.cnki.net

表3 基于ICF构建言语康复与语言和适应类课程的融合架构

Table 3 Integrated framework of speech therapy and key courses in Chinese language and adaptation based on ICF

阶段	核心任务	具体操作方法与工具	课程标准融合点
第一阶段:功能性评估与目标设定	构建ICF功能画像	资料分析:查阅医学诊断和教育档案 标准化评估:使用汉语图片词汇测验等工具评估b167,结果映射到ICF限定词 生态化观察:在课堂(生活语文)、游戏(生活适应)中观察d3、d7的表现 能力评估:在结构化情境中评估d3、d7的能力 环境评估:使用访谈和清单评估e类因素的促进或阻碍作用	评估内容参考康复训练的功能点 评估情境源于生活适应和生活语文
第二阶段:IEP制定与课程模块设计	设计功能导向的IEP	长期目标:设定与“参与”相关的目标(如能独立在社区商店购物) 短期目标:分解为具体的“活动”技能目标(如能阅读购物清单,能向店员问路) 支持性目标:明确需要改善的“身体功能”(如清晰说出“谢谢”) 支持策略:列出所需的环境支持(使用图片沟通板)	长期目标来自生活适应 短期目标来自生活语文 支持性目标来自康复训练
第三阶段:整合性干预实施	在生活主题中融合教康	示例模块:“超市购物” 课前准备(生活语文):制作图文购物清单,学习商品名称 课堂模拟(生活语文+康复):角色扮演购物对话。个别化支持:构音不清者练习商品发音(b320);无口语者练习使用AAC (e125)指认辅助器具 社区实践(生活适应):组织学生到真实超市购物,教师和治疗师现场提供支持 课后分享(生活语文):学生分享购物经历,练习叙事能力(d330)	主题源于生活适应 技能教学来自生活语文 个别化支持来自康复训练
第四阶段:持续性评估与调整	监测进展与调整方案	数据记录:持续记录儿童在自然情境中的沟通行为(如主动发起沟通的频率) 定期评估:定期(如每学期)重新进行ICF功能画像,对比前后变化 动态调整:根据评估结果,动态调整IEP目标和干预策略	评估标准应体现语言能力发展与就业成绩

构建功能性与多层次的言语和语言能力发展目标。IEP目标的设定是分层的，将最终的社会参与目标(源于生活适应)分解为具体的语言活动技能(源于生活语文)，再根据需要匹配底层的身体功能康复支持(源于康复训练)。这种自上而下又自下而上的目标设定方式，确保了所有干预都指向有意义的儿童实际生活目标和功能发展。

干预的情境化与融合性。言语与语言能力发展要求在真实的生活主题和情境下实施康复和教育综合性干预。言语康复不再是脱离情境的“练嘴皮子”，而是作为一种支持策略自然地融入到有意义的活动中。例如，构音训练的目标词汇直接来源于购物清单，这极大地提升了学习的动机和技能强化和应用的可能性。

中国知网 https://www.cnki.net

言语康复与语文教学过程的动态性与循环性。儿童的语言教育是一个持续循环的“评估-干预-再评估”过程。通过持续监测儿童的功能性进展，教师和治疗师可以不断优化干预方案，确保其始终适应儿童发展的动态变化。

为实现言语与语言康复目标，教学中应综合运用多种循证干预策略，如自然情境教学、视觉支持、同伴介导、AAC以及游戏化干预等[16]。

4 儿童言语康复与语言和适应类课程：基于ICF的整合性理论与实践

4.1 儿童言语康复与语言和适应类课程：基于ICF的功能导向的整合理论

ICF为理解和干预儿童的语言发展提供了一个创新性且以人为本的视角。传统上，特殊语言课程可能更侧重于学生的语言能力，而言语康复则聚焦于矫正特定的言语缺陷。ICF将儿童的语言能力置于一个动态的生态系统中进行考量，强调“功能”而非“缺陷”[17]。一个被诊断为“重度智力障碍”的儿童，在传统的缺陷模型下可能被认为教育价值有限。但在ICF架构下，关注的重点是在提供了合适的AAC设备(e125)、家人和教师的积极支持(e3、e4)以及结构化的环境(e2)后，儿童能在多大程度上参与沟通活动(d3)和家庭生活(d6)[18]。这种视角转变，促使教育者和康复师从“他不能做什么”的消极定论，转向“我们需要提供什么支持来让他能做什么”的积极方面。这不仅是一种理论上的创新，更是一种教育理念和以儿童为中心的价值观的升华，与我国《培智学校义务教育课程标准》中“立德树人”“最大限度地开发其潜能”的根本目标高度一致。

将ICF的功能导向理念应用于实践，意味着培智学校的语文教育与言语康复需要进行深刻的范式转换。①目标的转变，从知识本位到功能本位。语文教学的目标不应再是孤立地认识多少汉字或背诵多少课文，而应是这些语言知识能否帮助学生解决实际生活问题[19]。例如，“识字”的目标应具体化为“认识超市商品标签以完成购物”“认识公交站牌以独立出行”等[20]。言语康复的目标也不应仅仅是“能正确发出/sh/音”，而应是“能在需要帮助时清晰地说出‘老师’”。这种功能导向的目标设定，使得学习内容与儿童的内在需求和生活情境直接挂钩，极大地提升了学习的意义和动机[21]。②方法的转变，从分离式训练到融合式支持。功能导向要求干预必须在真实或高度仿真的情境中进行[22]。这意味着，言语治疗师需要更多地走进教室和生活场景，与教师协同合作，将康复策略嵌入到日常活动中[23]。教师也需要学习和运用基本的康复支持策略。例如，在小组讨论活动中，教师为有需要的学生提供视觉提示卡，治疗师则在一旁观察并对学生的语用技能进行即时反馈和辅导。这种融合模式确保了技能的即学即用，有效促进了泛化。

4.2 功能导向儿童语文与适应类课程的教学实践：融合言语功能、语言能力与社会适应目标

功能导向的语文与适应类课程的教学实践体系构建需要从课程整合、评估安置和个别化教学3个维度系统推进。

在课程整合维度，建立语言类相关课程的融合多元目标。未来的课程设计必须打破学科壁垒，将生活语文的语言能力目标、生活适应的社会适应目标和康复训练的言语功能目标进行系统性融合。课程应以生活主题或项目式学习为单位进行组织，在同一个主题下，自然地整合听、说、读、写、沟通、交往和底层康复的多元目标。

在评估安置维度，构建基于ICF的功能评估与安置体系[24]。应开发一套标准化的、基于ICF的评估流程和工具，对每位入学儿童进行全面的功能画像。评估结果不应仅仅生成一个分数，而应是一份详细的功能报告，清晰描述儿童在不同领域的优势、需求以及所需的支持。这份报告将成为决定学生教育安置(如普通班随班就读、特殊班级、培智学校)、资源配置和IEP制定的核心依据，使教育安置决策更加科学、循证和以学生为中心。

在个别化教学维度，建立功能导向的差异化与IEP课程。基于ICF的功能评估结果，为每位学生制定真正功能导向的IEP。IEP中的每一个目标都应与学生的生活参与直接相关，并明确所需的教学策略、康复支持和环境改造。在此基础上，教师在集体教学中实施高度的差异化教学，针对不同功能水平的学生提供不同的任务、材料和支持方式[25]。这样，课程实施才能真正做到“因材施教”，确保每个儿童都能在其“最近发展区”内获得有意义的学习和成长。

5 结论

儿童言语康复与语言和适应类课程的教育是一个复杂而多维的系统工程。以ICF的生物-心理-社会模型为理论，研究系统整合中国培智学校《生活语文课程标准》《康复训练课程标准》和《生活适应课程标

中国知网 https://www.cnki.net

准》，构建一个以儿童的言语和语言功能为导向的言语康复方案和语言和适应能力发展相关的课程体系。该整合方案强调从功能性评估出发，在真实的生活情境中，通过跨学科合作，为每一位特殊需要儿童提供个别化的、多模式的、循证的教育、康复干预和支持。通过实施整合性的康复方案和课程体系，提升儿童的言语与语言功能，促进儿童的功能性沟通，赋能特殊儿童的交流活动和社会参与，提升其社会适应能力和综合发展水平。

利益冲突声明：所有作者声明不存在利益冲突。

[参考文献]

[1] 易玲,周静,陈雪芬,等. 基于ICF的智力残疾儿童言语功能障碍和沟通活动受限特征与康复干预 [J]. 中国康复理论与实践, 2025, 31(4): 398-405.

YI L, ZHOU J, CHEN X F, et al. Characteristics and intervention of speech function impairments and communication limitation in children with intellectual disabilities based on ICF [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2025, 31(4): 398-405.

[2] 邱卓英,李欣,刘冯铂,等. 基于ICF的智力残疾模式、测量方法及社会支持系统研究[J]. 中国康复理论与实践, 2016, 22(4): 373-377.

QIU Z Y, LI X, LIU F B, et al. Framework, measurement, and social support of intellectual disability based on ICF [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2016, 22(4): 373-377.

[3] TASSÉ M, SCHALOCK R, LUCKASSON R. Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports [M]. 12th ed. Washington, D.C.: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2021.

[4] 杨亚茹,郝传萍. 基于ICF构建智力残疾儿童适应性体育课程体系[J]. 中国康复理论与实践, 2022, 28(6): 659-669.

YANG Y R, HAO C P. Construction of adapted physical education curriculum for children with intellectual disabilities using ICF [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2022, 28(6): 659-669.

[5] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Developmental disability basics [EB/OL]. (2025-06-02) [2025-06-22]. https://www. cdc. gov/child-development/about/developmental-disability-basics.html.

[6] World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) [EB/OL]. (2025-02-14)[2025-04-20]. https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases.

[7] 周静,张晓晓,丁忠冰,等. 智力与发展性残疾儿童言语与语言障碍康复的系统综述[J]. 中国康复理论与实践, 2024, 30(8): 894-902.

ZHOU J, ZHANG X X, DING Z B, et al. Effect of speech and language rehabilitation on children with intellectual and developmental disabilities: a systematic review [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2024, 30(8): 894-902.

[8] 中华人民共和国教育部. 培智学校义务教育生活语文课程标准[S/OL]. (2016-12-02)[2025-03-10]. https://www.ictr.edu.cn/Uploads/File/2022/05/23/33_% E5%9F% B9%E6%99%BA% E5%AD% A6%E6%A0%A1%E4%B9%89%E5%8A% A1% E6%95%99%E8%82%B2%E7%94%9F% E6%B4%BB% E8% AF% AD% E6%96%87%E8%AF% BE% E7%A8%8B% E6% A0%87%E5%87%86%EF% BC% 882016%E5%B9%B4%E7% 89%88%EF%BC%89.20220523162050.pdf.

[9] 中华人民共和国教育部. 培智学校义务教育康复训练课程标准[S/OL]. (2016-12-02)[2025-05-11]. https://www.ictr.edu.cn/Uploads/File/2022/05/23/36_% E5%9F% B9%E6%99%BA% E5%AD% A6%E6%A0%A1%E4%B9%89%E5%8A% A1% E6%95%99%E8%82%B2%E5%BA%B7%E5%A4%8D%E8% AE% AD% E7%BB% 83%E8%AF% BE% E7%A8%8B% E6% A0%87%E5%87%86%EF% BC% 882016%E5%B9%B4%E7% 89%88%EF%BC%89.20220523162202.pdf.

[10] 中华人民共和国教育部. 培智学校义务教育生活适应课程标准[S/OL]. (2016-12-02)[2025-05-10]. https://www.ictr.edu.cn/Uploads/File/2022/05/23/41_%E5%9F%B9%E6%99%BA% E5%AD% A6%E6%A0%A1%E4%B9%89%E5%8A% A1% E6%95%99%E8%82%B2%E7%94%9F% E6%B4%BB% E9% 80%82%E5%BA% 94%E8%AF% BE% E7%A8%8B% E6% A0%87%E5%87%86%EF% BC% 882016%E5%B9%B4%E7% 89%88%EF%BC%89.20220523162356.pdf.

[11] 世界卫生组织. 国际功能、残疾和健康分类(国际中文增补版)[M]. 邱卓英,译. 日内瓦: 世界卫生组织, 2015.

World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health-(International Chinese Supplement) [M]. QIU Z Y, trans. Geneva: World Health Organization, 2015.

[12] MCCARTY T V, LIGHT J C. Supporting peer interactions for students with complex communication needs in inclusive settings: paraeducator roles [J]. Perspect ASHA Spec Interest Groups, 2022, 7(1): 229-244.

[13] ODOM S L, HALL L J, SUHRHEINRICH J. Implementation science, behavior analysis, and supporting evidence-based practices for individuals with autism [J]. Eur J Behav Anal, 2020, 21(1): 55-73.

[14] WOOD J J, MCLEOD B D, KLEBANOFF S, et al. Toward the implementation of evidence-based interventions for youth with autism spectrum disorders in schools and community agencies [J]. Behav Ther, 2015, 46(1): 83-95.

中国知网 https://www.cnki.net

[15] HYMAN S L, LEVY S E, MYERS S M. Identification, evaluation, and management of children with autism spectrum disorder [J]. Pediatrics, 2020, 145(1): e20193447.

[16] THIEMANN-BOURQUE K, FELDMILLER S, HOFFMAN L, et al. Incorporating a peer-mediated approach into speech-generating device intervention: effects on communication of preschoolers with autism spectrum disorder [J]. J Speech Lang Hear Res, 2018, 61(8): 2045-2061.

[17] 邱卓英,李沁燚,陈迪,等. ICF-CY理论架构、方法、分类体系及其应用[J]. 中国康复理论与实践, 2014, 20(1): 1-5.
QIU Z Y, LI Q Y, CHEN D, et al. ICF-CY: Framework, approach, classification and implementation [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2014, 20(1): 1-5.

[18] SIMEONSSON R J, LEONARDI M, LOLLAR D, et al. Applying the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) to measure childhood disability [J]. Disabil Rehabil, 2003, 25(11-12): 602-610.

[19] LIGHT J, MCNAUGHTON D. Designing AAC research and intervention to improve outcomes for individuals with complex communication needs [J]. Augment Altern Commun, 2015, 31 (2): 85-96.

[20] KASARI C, SHIRE S, SHIH W, et al. Spoken language outcomes in limited language preschoolers with autism and global developmental delay: RCT of early intervention approaches [J]. Autism Res, 2023, 16(6): 1236-1246.

[21] BROWDER D M. Teaching students with moderate and severe disabilities [M]. 2nd ed. New York: The Guilford Press, 2020.

[22] BROCK M, BIGGS E, CARTER E, et al. Implementation and generalization of peer support arrangements for students with severe disabilities in inclusive classrooms [J]. J Special Educ, 2015, 49(4): 23-45.

[23] GULBOY E, YUCESOY-OZKAN S, RAKAP S. Embedded instruction for young children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of single-case experimental research studies [J]. Early Child Res Q, 2023, 63(2): 181-193.

[24] MCNEILLY L G. Using the International Classification of Functioning, Disability and Health framework to achieve interprofessional functional outcomes for young children: a speech-language pathology perspective [J]. Pediatr Clin North Am, 2018, 65(1): 125-134.

[25] PARSONS L, CORDIER R, MUNRO N, et al. A randomized controlled trial of a play-based, peer-mediated pragmatic language intervention for children with autism [J]. Front Psychol, 2019, 10(3): 1960.

(收稿日期:2025-07-08)

中国知网 https://www.cnki.net